

Les blocs périmédullaires chez l'adulte

Question 8 — Agents de l'analgésie postopératoire périmédullaire



Périmètre limité — installment 4/n : ce document source compte 15 « Questions » cliniques et 369 citations de grade au total. Cette fiche couvre INTÉGRALEMENT la Question 8 (analgésie postopératoire par voie périmédullaire : agents, indications, monitoring/surveillance). La Question 6 (travail obstétrical) reste EXCLUE — superseded par une fiche séparée plus récente (HAS 2025, « Douleur de l'accouchement »). Les Questions 1-2, 3-5 et 7 sont couvertes par des fiches séparées. Les Questions 9 à 15 (terrains cardiovasculaire/respiratoire/neurologique/infectieux spécifiques, gestion de l'échec, facteurs de risque de complications) ne sont PAS couvertes ici — installments futurs.

Grille EBM classique — **A** : essais randomisés de forte puissance/méta-analyses ; **B** : essais randomisés de faible puissance/études de cohorte ; **C** : cas-témoins/études rétrospectives. Aucune citation « grade D », « accord professionnel » ou « avis d'experts » ponctuelle dans le périmètre de cette fiche (disclosed en page 1) — chips « D »/« AE » donc absents ici. Fiche limitée à la Question 8/15 du document (analgésie postopératoire périmédullaire : agents, indications, monitoring).

A

B

C

Question 8 — Agents de l'analgésie postopératoire périmédullaire

Précision du source : après injection périurale, environ 10 % de l'AL traverse la dure-mère (absorption dans la graisse périmédullaire, résorption vasculaire, diffusion par les trous de conjugaison).

Anesthésiques locaux

Catégorie	Recommandation	Grade
AL — Lidocaïne	Contre-indiquée par voie intrathécale : neurotoxicité (syndrome de la queue-de-cheval, syndrome d'irritation radiculaire transitoire), retirée du marché dans cette indication.	A
AL — Alternatives	De nombreuses alternatives à la lidocaïne existent, pour une même efficacité clinique.	A
AL — Bupivacaïne	Molécule la plus cardiotoxique expérimentalement parmi les AL (mélange racémique).	A
AL — Bupivacaïne IT	ED95 intrathécale ≈ 0,06 mg/cm de taille ; en deçà, associer un adjuvant (morphinique).	A
AL — Bupivacaïne péri.	MLAC périurale 0,048–0,067 %, majorée à 0,140 % en fin de travail/dystocie obstétricale.	A
AL — Ropivacaïne	AL de longue durée d'action, expérimentalement le moins cardiotoxique.	A
AL — Lévocabupivacaïne	Cardiotoxicité intermédiaire entre bupivacaïne et ropivacaïne.	A
AL — Associations	Résultats cliniques intermédiaires (inférieurs à la molécule la plus puissante), avec risque d'additivité voire de synergie de toxicité.	C

Opiacés

Catégorie	Recommandation	Grade
Opiacés	Action analgésique synergique des opioïdes et des AL, par voie intrathécale et périurale.	A
Opiacés	Cette synergie permet de réduire la concentration minimale efficace des AL (MLAC).	B
Morphine	Action spinale spécifique, temps de résidence prolongé dans le LCR.	A
Morphine	Analgésie de 10-12h (jusqu'à 24h), délai d'action plus long que les opioïdes liposolubles.	A
Opioïdes liposolubles	Action principalement systémique ; une action segmentaire (ganglions rachidiens) ne peut être exclue.	B
Opioïdes liposolubles	Action segmentaire spinale préférentielle en administration en bolus, systémique en administration continue.	C
Opioïdes liposolubles	Délai d'action plus rapide et durée d'action plus courte que la morphine.	A

Les blocs périmédullaires chez l'adulte

Question 8 — Agents de l'analgésie postopératoire périmédullaire



Catégorie	Recommandation	Grade
Association triple	Morphine + opioïde liposoluble + AL : réduit la dose de chacun tout en gardant leur bénéfice respectif.	C
Sécurité opiacés	Pic du risque de dépression respiratoire : 6e heure (jusqu'à 24h) pour la morphine, contre 20 min (durée 6-8h) pour fentanyl/sufentanil.	B

Repères pratiques non gradés (doses) :

- Morphine : 1-4 mg en péri-dural, 100-300 µg en intrathécal (doses réduites chez le sujet âgé : ne pas dépasser 200 µg intrathécal / 3 mg péri-dural).
- Fentanyl intrathécal 10 (5-25) µg, sufentanil intrathécal 5 (5-10) µg ; péri-dural : fentanyl 2 (2-20) µg/ml, sufentanil 0,5 (0,25-0,75) µg/ml.
- Effets secondaires dose-dépendants : nausées/vomissements plus fréquents avec la morphine ; prurit plus fréquent par voie intrathécale (ne limite généralement pas l'utilisation) ; la dépression respiratoire (cf. tableau) reste le facteur limitant principal.

Agents agonistes alpha2-adrénergiques et kétamine

Catégorie	Recommandation	Grade
Adrénaline	À des concentrations $\geq 1,5$ µg/ml, diminue le délai d'installation du bloc après administration intrathécale d'AL.	B
Clonidine	Absence de neurotoxicité : en fait un complément de choix des morphiniques.	A
Kétamine	Contre-indiquée par voie périmédullaire : neurotoxicité du chlorobutanol (conservateur) ; une solution sans conservateur pourrait être envisagée mais le recul clinique est insuffisant.	A

Repères pratiques non gradés :

- Clonidine : prolonge les blocs sensitif et moteur des AL et permet des doses d'AL plus faibles ; effets secondaires (hypotension, bradycardie, somnolence) dose-dépendants, limitant les doses à 15-75 µg intrathécal et 4-5 µg/ml péri-dural.

Les blocs périmédullaires chez l'adulte

Question 8 — Indications de l'analgésie périmédullaire postopératoire



Question 8 — Indications de l'analgésie périmédullaire postopératoire

Repères non gradés : l'analgésie périurale (APD), de qualité et fiabilité supérieures, est la référence à laquelle les autres techniques d'analgésie aspirent — supérieure à l'analgésie parentérale pour quasiment tous les types de chirurgie. La rachianalgésie est plus limitée dans le temps et par les médicaments utilisables. Les indications ci-dessous sont établies par type de chirurgie, en tenant compte de la qualité d'analgésie, des bénéfices attendus et des risques de chaque technique.

Prérequis pour une analgésie périurale postopératoire

Catégorie	Recommandation	Grade
Prérequis APD	Chirurgie abdominale/thoracique : associer un AL à faible concentration à un morphinique pour une analgésie supérieure aux autres techniques.	A
Prérequis APD	Cathéter inséré au milieu de la zone des dermatomes à bloquer, le plus souvent au niveau thoracique.	B
Prérequis APD	Administration des médicaments adaptée au mieux par le patient lui-même (PCA).	C

Chirurgie thoracique et cardiaque

Catégorie	Recommandation	Grade
Thoracotomie	L'APD thoracique aux AL, plus ou moins associée à un morphinique, est la technique la plus efficace.	A
Thoracotomie	Bloc paravertébral vs APD thoracique comparés par 2 études aux résultats discordants (l'une favorable au paravertébral avec moins d'effets secondaires, l'autre favorable à l'APD sur les 24 premières heures).	B
Thoracotomie	Fonction respiratoire améliorée et complications pulmonaires diminuées par l'APD (AL et/ou morphinique).	A
Thoracotomie	Diminution de l'incidence des troubles du rythme cardiaque.	C
Thoracotomie	Diminution de l'incidence des douleurs chroniques post-thoracotomie.	C
Chir. cardiaque	Analgésie périmédullaire d'excellente qualité, supérieure à la voie parentérale (durée plus limitée pour la voie rachidienne).	A
Chir. cardiaque	Seule l'APD (pas la rachianalgésie) diminue la morbidité postopératoire.	B
Chir. cardiaque	Diminution de la réaction de stress chirurgical.	C
Chir. cardiaque	Diminution de l'incidence des troubles du rythme cardiaque.	B
Chir. cardiaque	Diminution des complications respiratoires.	B
Chir. cardiaque	Diminution des complications neurologiques.	B
Chir. cardiaque	Diminution de la durée de ventilation postopératoire.	B

Chirurgie de l'œsophage et chirurgie abdominale majeure

Catégorie	Recommandation	Grade
Chir. œsophage	L'APD diminue la douleur postopératoire.	A
Chir. œsophage	Diminution de la réaction de stress chirurgical.	C
Chir. œsophage	Diminution de l'incidence des complications respiratoires.	B
Chir. œsophage	Réduction de la durée de ventilation postopératoire.	C

Les blocs périmédullaires chez l'adulte

Question 8 — Indications de l'analgésie périmédullaire postopératoire



Catégorie	Recommandation	Grade
Chir. œsophage	Réduction de la durée totale d'hospitalisation.	C
Abdo. majeure	Association péridurale AL + morphinique : analgésie supérieure à la morphine péridurale seule, elle-même $\geq$ morphine parentérale.	A
Abdo. majeure	Cette association réduit les scores de douleur d' ≈ 15 mm sur les 48 premières heures, comparée à la morphine parentérale.	A
Abdo. majeure	Morphine intrathécale : analgésie d'excellente qualité mais de durée moindre (≈ 20 h sans réinjection).	C
Abdo. majeure	AL péridurale (blocage sympathique) : glycémie et tolérance aux sucres normalisées.	C
Abdo. majeure	Catabolisme et consommation d'O ₂ diminués, bilan azoté positif.	C
Abdo. majeure	Taux de cortisol/catécholamines/aldostérone/rénine/ADH diminués ; effet sur la fonction rénale minime.	C
Abdo. majeure	APD (AL ou morphinique) : diminution des épisodes d'ischémie myocardique et des troubles du rythme, vs voie parentérale.	C
Abdo./thoracique	Incidence des complications thromboemboliques NON diminuée par l'APD.	B
Abdo. majeure	Oxygénation artérielle améliorée par l'APD.	A
Abdo. majeure	Mécanique respiratoire améliorée par l'APD.	C
Thoraco-abdo majeure	Diminution de l'incidence des complications respiratoires graves.	A
Thoraco-abdo majeure	Extubation plus précoce.	B
Abdo. majeure	Ponction lombaire : reprise du transit NON accélérée par l'APD.	C
Abdo. majeure	Ponction thoracique (AL + morphinique ≥ 48 h) : accélère la reprise du transit.	A
Abdo. majeure	Statut neurologique postopératoire potentiellement amélioré.	B

Repères pratiques non gradés — hépatectomie :

- Bénéfices superposables à ceux de la chirurgie digestive majeure (plusieurs études incluent des hépatectomies) ; particularité : risque de troubles de l'hémostase postopératoire, dont découlent les précautions de gestion du cathéter péridural.

Urologie, gynécologie, chirurgie de l'aorte et vasculaire périphérique

Catégorie	Recommandation	Grade
Urologie	Chirurgie vésicale transpéritonéale : réduction de l'iléus postopératoire, moindre fatigue, déambulation plus rapide.	B
Gynécologie	Prolongation postopératoire de l'APD : analgésie de meilleure qualité que par voie systémique (hystérectomie).	C
Aorte abdominale	APD utile pour l'analgésie.	A
Aorte abdominale	Réduction de l'incidence des complications respiratoires.	A
Aorte abdominale	Réduction de la durée de ventilation.	A
Aorte abdominale	Pas d'impact sur les complications cardiovasculaires.	A
Aorte abdominale	Risque de complications à type d'hématome péridural.	C

Les blocs périmédullaires chez l'adulte

Question 8 — Indications de l'analgésie périmédullaire postopératoire



Catégorie	Recommandation	Grade
Vascul. périphérique	Pas d'impact sur la mortalité ni sur les complications cardiaques et respiratoires.	B
Vascul. périphérique	Effet protecteur sur la thrombose du greffon.	A
Vascul. périphérique	Utilisation peropératoire jugée inutile.	C

Repères pratiques non gradés :

- Urologie (prostatectomie) : effet analgésique préventif peropératoire possible ; pas de preuve d'effet sur la morbi-mortalité ; indication postopératoire non clairement établie après prostatectomie, mais potentiellement indiquée pour la chirurgie transpéritonéale (ex. cystectomie).
- Gynécologie (hystérectomie) : effet préventif peropératoire d'intérêt très limité ; pas de preuve d'effet sur la morbi-mortalité ; rachianalgésie à faible dose de morphine (< 0,1 mg) possible.
- Chirurgie de l'aorte : le cathéter doit être posé en préopératoire (anticoagulation peropératoire) — son utilisation peropératoire n'est pas utile.

Amputation de membre et chirurgie orthopédique

Repères pratiques non gradés — arthroplastie totale de hanche (PTH) :

- Utilisation peropératoire réduirait le saignement et la thrombose veineuse (efficacité inférieure aux HBPM) ; impact sur la morbi-mortalité controversé ; en postopératoire, la poursuite de l'APD améliore l'analgésie sans améliorer la convalescence et expose à un risque de rétention urinaire, d'hypotension et de problèmes techniques.
- L'APD postopératoire N'EST PAS indiquée après PTH (faible niveau de douleur, faible rentabilité sur la convalescence) ; une rachianesthésie à faible dose de morphine (0,1 mg) est parfois proposée mais sa tolérance est médiocre (risque de dépression respiratoire).

Catégorie	Recommandation	Grade
Amputation membre	APD utile pour l'analgésie postopératoire immédiate.	C
Amputation membre	Incertitude sur la prévention des douleurs de membre fantôme.	C
Amputation membre	Utilisation pré- et peropératoire souhaitable.	C
Arthroplastie genou	APD postopératoire immédiate utile.	C
Arthroplastie genou	Rééducation plus efficace, durée de séjour réduite.	C
Arthroplastie genou	Utilisation peropératoire souhaitable pour limiter la thrombose.	C

Repères pratiques non gradés :

- Genou : indications restent limitées par les effets secondaires ; le bloc fémoral est plus facile et tout aussi efficace ; la rachianalgésie est une alternative moins intéressante.
- Au total : l'APD bien conduite (respect des contre-indications, niveau de ponction adéquat, association AL + morphinique, adaptation des doses) procure une excellente analgésie au repos et à la mobilisation, supérieure aux autres techniques d'analgésie postopératoire — sauf blocs périphériques en orthopédie et bloc paravertébral en chirurgie thoracique. Elle doit s'intégrer dans un programme multimodal de réadaptation accélérée.

Les blocs périmédullaires chez l'adulte

Question 8 — Monitoring, surveillance & sources



Question 8 — Monitoring et modalités de surveillance postopératoire

Disclosure méthodologique : à la différence des deux sous-sections précédentes, cette sous-section ne comporte AUCUNE citation (grade X) individuelle dans le texte source. Le texte source l'introduit ainsi : « Les recommandations reposent sur la réglementation, d'une part, et sur un consensus professionnel, d'autre part » — une justification méthodologique globale, non rattachée à une phrase précise. Elle n'est donc pas retranscrite en lignes de tableau gradées (ce qui fabriquerait artificiellement un chip que le source n'attribue à aucun item), mais intégralement condensée en repères pratiques non gradés ci-dessous.

Cadre réglementaire :

- Décret 95-100 du 6 septembre 1995 : le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances de son malade et l'assister moralement.
- Article L. 1110-5 du code de la santé publique : toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur, qui doit être prévenue, évaluée, prise en compte et traitée en toute circonstance.
- Article L. 710-3-1 du code de la santé publique : chaque établissement de santé doit définir, dans son projet d'établissement, un programme d'actions pour améliorer la prise en charge de la douleur.
- Décret n° 2002-194 du 11 février 2002 (actes infirmiers) : l'infirmier(e) est habilité à entreprendre et adapter les traitements antalgiques dans le cadre de protocoles écrits/datés/signés par un médecin, et à injecter dans les cathéters périduraux ou intrathécaux posés par un médecin (après que celui-ci en ait fait la première injection), à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment.

Information du patient et cahier des charges :

- Le patient doit être informé des objectifs et modalités de l'analgésie périmédullaire dès la consultation d'anesthésie ; le mode d'évaluation de la douleur (EVA, EVS) est adapté au patient.
- Le protocole d'analgésie postopératoire est préparé en consultation et débute en période peropératoire ; en fin d'intervention, la prescription est personnalisée, nominative, horodatée et paraphée par le médecin anesthésiste ; un protocole de service (technique, analgésiques/doses, surveillance, conduite à tenir en cas d'effet secondaire) peut compléter la prise en charge en service de chirurgie.

Fréquence et contenu de la surveillance :

- Surveillance régulière plusieurs fois par période de 24h ; rapprochée dans l'heure suivant l'installation ou un changement de dose, puis toutes les 2 à 4 heures selon le patient et le type de chirurgie ; basée sur une échelle de douleur (EVA/EVS) au repos et à la mobilisation.
- Critères cliniques prioritaires : score d'éveil/sédation et fréquence respiratoire (nécessitent une formation adaptée des équipes soignantes) ; évaluation des blocs sensitif et moteur (étendue, intensité) au moins une fois par équipe infirmière.
- Après injection intrathécale de morphine : surveillance rapprochée en soins continus ou soins intensifs pendant 24 heures, SAUF pour les patients ayant reçu une dose inférieure à 0,2 mg.
- Les feuilles de surveillance doivent comporter : niveaux d'analgésie (EVA/EVS, au repos et à la mobilisation) et de sédation, paramètres cardiovasculaires (pression artérielle, fréquence cardiaque) et ventilatoires (fréquence respiratoire), blocs sensitif et moteur (si APD analgésique), effets indésirables mineurs (nausées, vomissements, prurit, rétention urinaire) et complications mécaniques liées aux cathéters, consommation analgésique (PCA/PCEA), et les conduites à tenir en cas d'effet secondaire.

Sources et avertissement

Document source : SFAR/Sofcot/Sofmer, « Les blocs périmédullaires chez l'adulte », Recommandations pour la Pratique Clinique, présentées le 24 septembre 2005 (47e congrès SFAR), Annales Françaises d'Anesthésie et de Réanimation 26 (2007) 720-752.

URL source : <https://sfar.org/les-blocs-perimedullaires-chez-ladulte/>

Couverture : Question 8/15 uniquement (analgésie postopératoire par voie périmédullaire : agents, indications, monitoring/surveillance) — 71 recommandations gradées (A:28, B:17, C:26). Aucune citation « grade D », « accord professionnel » ou « avis d'experts » ponctuelle dans le périmètre de cette Question (disclosed en page 1) — la sous-section Monitoring repose sur une justification méthodologique globale (« réglementation » + « consensus professionnel »), non rattachée à une recommandation individuelle, et est donc intégralement condensée en repères pratiques non gradés plutôt qu'en lignes de tableau. La Question 6 (travail obstétrical) est EXCLUE — superseded par une fiche séparée plus récente (HAS 2025). Les Questions 1-2, 3-5 et 7 sont couvertes par des fiches séparées. Les Questions 9 à 15 (terrains spécifiques, échec, facteurs de risque de complications) ne sont pas couvertes ici — hors périmètre de cette fiche, installments futurs. Argumentaire scientifique détaillé (document source complet) non reproduit.

Avvertissement : cette fiche est une synthèse indépendante et PARTIELLE (Question 8 uniquement, sur 15). Elle ne remplace pas le texte intégral — en particulier pour le travail obstétrical (voir la fiche HAS 2025 dédiée), les contre-indications générales, la technique de réalisation des blocs, la césarienne, ou tout terrain spécifique. Cette fiche n'est ni éditée ni validée par la SFAR.